2.1.3.8. 입퇴실 절차 – 조혈모세포이식병동

제 정 일	2010.12.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	혈액내과, 혈액암센터, 조혈모세포이식팀				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.1.3 중환자실/특수치료실 입실 절차 JCI Standard 7th Edition: ACC.2.3, PCI.12

제1조 (목적)

1. 집중치료가 필요한 환자에게 한정된 자원을 효율적으로 활용하여 적절한 의료서비스를 제공하기 위해 표준화된 조혈모세포이식병동 입퇴실 절차를 준수하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 조혈모세포이식병동(HSCT(Hematopoietic Stem Cell Transplantation) Ward): 조혈모세포이식을 시행할 수 있는 병동으로 적절한 감염예방을 위해 HEPA filtration을 포함한 공조시스템 등 제반 시설이 기준에 맞게 설치 운영되어 정해진 무균도가 유지되는 병동을 의미하며 무균도에 따라 무균실 및 격리실로 구성된다.
2. 무균도는 CLASS 로 표시하며, 무균실 CLASS 100 이하, 무균실 전실 CLASS 1,000 이하, 격리실 환자침상 CLASS 1,000 이하, 격리실 CLASS 10,000 이하, 그리고 복도처치실, 간호사실, 및 부속실 등 CLASS 10,000 ~ 100,000 유지를 원칙으로 한다.

제3조 (절차)

1. 입실기준
   1) 무균실
      (1) 혈액암, 난치성 혈액질환, 소아혈액암 또는 고형암, 자가면역질환 등에 대한 치료로 조혈모세포이식술을 시행받기 위해 입원하는 환자가 일차 입실대상이며 '무균실 사용에 대한 건강보험 급여기준'에 준하여 이식병실료가 적용된다.
      (2) 일차 입실대상자가 없는 경우, 일반상급병실로 전용할 수 있으며, 일반상급병실로 사용되는 경우 일반상급병실 운영에 준한다. 단, 입원 시 환자에게 일차 입실대상자의 입원 목적을 위해 무균실로 상시 전환될 수 있으며, 이 경우 의료진의 전·퇴실 결정에 따라야 함을 설명하고 동의를 받아야 한다.
      (3) 이식환자에 대한 병실배정 및 입원일은 주치의(담당교수)가 이식순서, 이식환자의 임상적 상황, 병실운영상황 등을 고려하여 결정하며, 조혈모세포이식팀 월례 이식회의에서 최종 결정한다.
   2) 격리실
      (1) 조혈모세포이식환자, CAR-T 등의 세포치료를 받는 환자, 급성 이식편대숙주반응, 항암화학요법 후 면역저하, 장기간 면역저하가 예상되는 환자 등이 입실대상이다.

(2) 일반혈액검사결과 상 호중구 500/μl 이하인 경우 우선 고려 대상이 된다.
(3) 일차 입실대상자가 없는 경우, 일반상급병실로 전용할 수 있으며, 일반상급병실로 사용되는 경우, 일반상급병실 운영에 준한다. 단, 입원 시 환자에게 일차 입실대상자의 입원 목적을 위해 격리실로 상시 전환될 수 있으며, 이 경우 의료진의 전·퇴실 결정에 따라야 함을 설명하고 동의를 받아야 한다.
(4) 주치의(담당교수)가 파트장과 협의 후 입실을 최종 결정한다.

2. 입실 절차
1) 의료진은 입실 시 환자 및 보호자에게 입실 필요성을 설명하고 동의를 받는다.
2) 입실 시점의 환자 상태를 평가하고 입실 기준에 부합하는지를 의무기록에 기록한다.

3. 전·퇴실 기준
1) 무균실
(1) 이식 후 절대호중구수 1,000/μl 이상으로 회복되고 3일 이상 유지되면 전·퇴실 가능하다.
(2) 이식 후 절대호중구수가 500/μl 이상 1,000/μl 미만인 경우에도 주치의(담당교수) 판단에 따라 전·퇴실을 고려할 수 있다.
(3) 주치의(담당교수)가 환자의 임상 상황 때문에 무균실 치료가 필요하다고 판단하는 경우 재실을 연장할 수 있다.
(4) 감염성 질환에 이환된 환자의 전·퇴실시에는 환자의 상태에 따라 공기매개 주의, 비말주의, 접촉주의를 추가로 적용한다.
(5) 기도삽관 또는 기계호흡 등의 집중치료가 예상되거나 필요한 경우는 중환자실 입실 기준에 준하여 중환자실로 전실함을 원칙으로 한다.
(6) 환자가 일반상급병실로 사용하는 경우, 입원 시 동의한 대로 병실이 일차 입원대상자의 입원을 위한 무균실로 전환되어야 하면 상시로 전·퇴실될 수 있다.
(7) 전·퇴실 시점은 주치의(담당교수)와 파트장의 협의 하에 결정한다.
2) 격리실
(1) 절대호중구수 1,000/μl 이상 회복 후 과립구생성촉진인자의 도움없이 계속 절대호중구수 1,000/μl 이상 유지가 기대되는 경우에 전·퇴실을 고려한다.
(2) 주치의(담당교수)가 환자의 임상 상황 때문에 격리실 치료가 필요하다고 판단하는 경우, 재실을 연장할 수 있다.
(3) 감염성 질환에 이환된 환자의 전·퇴실 시에는 환자의 상태에 따라 공기매개 주의, 비말주의, 접촉주의를 추가로 적용한다.
(4) 기도삽관, 기계호흡 등의 집중치료가 예상되거나 필요한 경우는 중환자실 입실 기준에 준하여 중환자실로 전실함을 원칙으로 한다.
(5) 환자가 일반상급병실로 사용하는 경우, 입원 시 동의한 대로 일차 입원대상자의 입원을 위해 격리실로 전환되어야 하면 상시로 전·퇴실될 수 있다.
(6) 전·퇴실 시점은 조혈모세포이식병동 격리실 퇴실 기준에 따라 주치의(담당교수)와 파트장의 협의 하에 결정한다.

4. 전·퇴실 절차
   1) 전·퇴실 기준에 따라 주치의(담당교수)가 환자의 퇴실을 결정한다.
   2) 의료진은 전·퇴실 시 환자 상태를 평가하고 전·퇴실 기준에 부합하는지를 의무기록에 기록한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2010년 12월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)